

Дослідження (магнітно-резонансна томографія) виконано на 1,5Тл МРТ системі Магнетом Аванто fit виробництва Siemens, Німеччина.

ПІБ пацієнта: Жерліцина Анастасія Станіславівна

Дата народження: 25.04.1976

Дата дослідження: 16.06.2023

№ дослідження: CMDI1200

Назва дослідження: МРТ головного мозку до та після контрастування

Контрастний засіб: Дотавіст

Протокол сканування: виконані T2WI, DWI, SWI томограми головного мозку в аксіальній та сагітальній проекціях, T2_spc_da-fl_iso, T1mpr, T1mpr + C з подальшою мультипланарною реконструкцією



Анамнестичні дані: лейоміосаркома матки T2NxM1. Стан після 4-х циклів ХТ по протоколу Гемцитабін+Доцетаксел+Авастин з прогресією в печінці. Виявлено мутації Kit, з приводу чого рекомендовано прийом Пазопанібу (згідно консультаційного висновка онколога від 4.01.2023р).

МРТ в динаміці від 20.01.2023.

На серії МР-томограм головного мозку зберігаються раніше описані дифузні осередки гіперінтенсивного МР-сигналу на T2WI та T2blade dark-fl в кортикально-субкортикальних відділах обох півкуль головного мозку (переважно в тім'яних областях), проте, зі значним їх регресом у вигляді зменшення розмірів, менш гіперінтенсивного МР-сигналу на T2_spc_da-fl_iso та з регресом накопичення контрастного препарату в їх структурі. Появи нових вогнищ не визначається.

Зберігається вогнище внутрішньомозкової геморагії в лівій потиличній області загальними умовними розмірами 11x7,5x7,5мм (зменшилось в розмірах), з ознаками обмеження дифузії з мінімальним перифокальним набряком мозкової речовини, шириною до 3мм; також визначається дрібний осередок постгеморагічних змін в правій потиличній області.

За ходом субарахноїдальних просторів в лобних областях зберігаються ділянки гіпоінтенсивного МР-сигналу на SWI, підвищеного на T2WI та T2_spc_da-fl_iso, які не визначаються на DWI та не накопичують контрастний препарат (можливо, наслідки локального САК чи геморагічного просякнення).

Серединні структури без латерального зміщення. Бічні шлуночки мозку симетричні, в розмірах не змінені, IV шлуночок розміщений по середній лінії. Розмежування сірої та білої речовини чітке.

Перивентрикулярні зони лейкоареозу шириною до 2мм.

Мозолисте тіло, базальні ганглії, мезенцефальні структури, структури задньої черепної ями, стовбур мозку ділянок патологічної зміни МР-сигналу не містять.

Краніовертебральний перехід: мигдалики мозочка без ознак пролабування у великий потиличний отвір.

Турецьке сідло: розташоване типово, звичайної конфігурації. Стінки рівні, контури гладкі, чіткі. Лійка гіпофіза розташована чітко по центру. Гіпофіз бобоподібної форми, верхній край симетричний.

Хіазма, зорові нерви без особливостей.

Пневматизація приносних пазух не порушена.

Висновок: МР-картина патологічних змін в головному мозку, що значно зменшились за інтенсивністю і поширеністю в порівнянні з МРТ-обстеженням від 20.01.2023, враховуючи дані клініки та анамнеза, попередніх обстежень, локалізацію та МР-характеристики, може відповідати наслідкам posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES). В порівнянні з попереднім МРТ обстеженням від 20.01.2023 визначається зменшення розмірів та трансформація вмісту внутрішньомозкового крововиливу в лівій потиличній частці мозку.

Доцільні: клініко-томографічне співставлення, МР-контроль в динаміці, спостереження невролога.

Лікар

Саченок Неллі Борисівна

